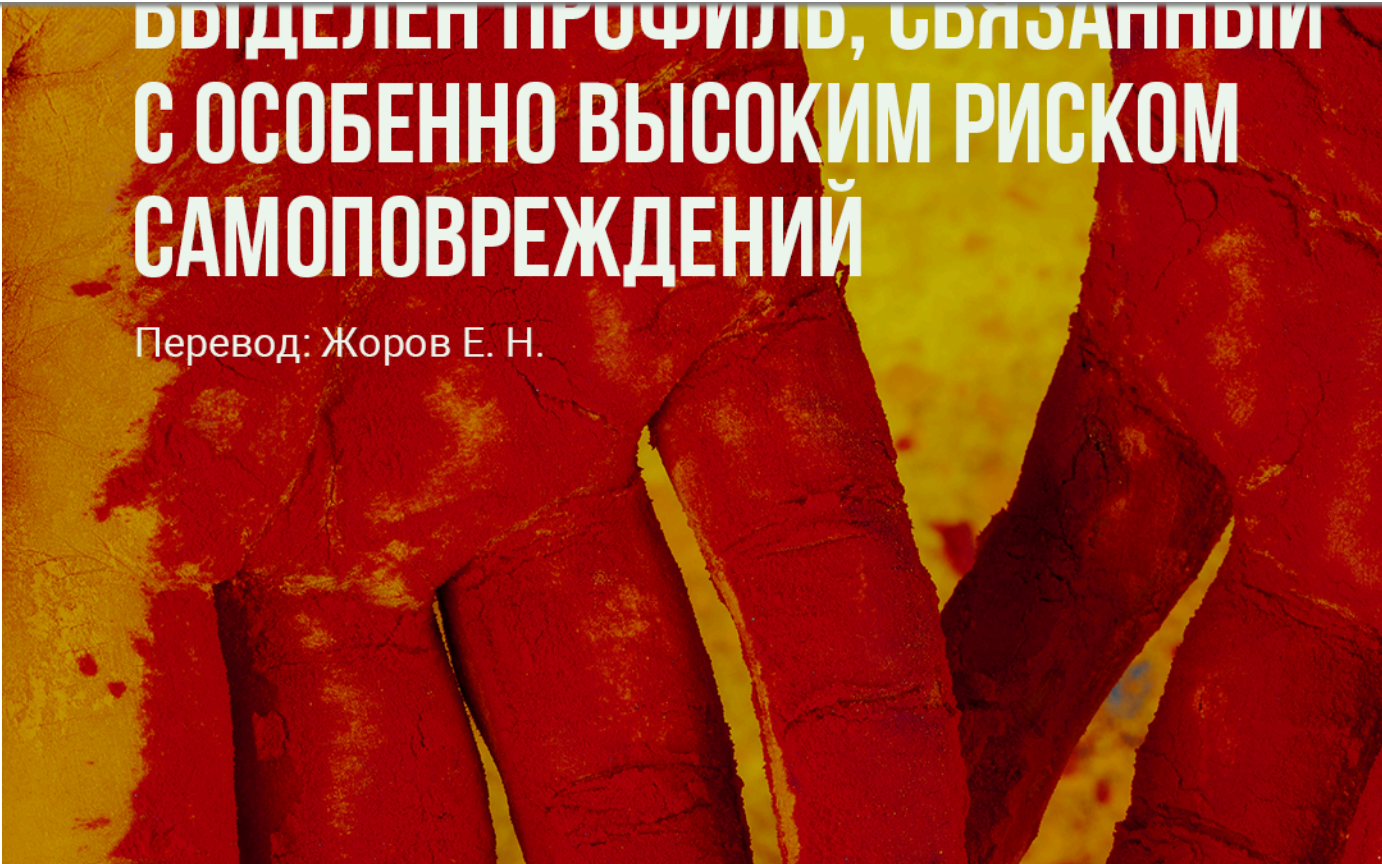




профиль, связанный с особенно высоким риском самоповреждений

24.04.2026 / [Новости](#)



ВЫДЕЛЕН ПРОФИЛЬ, СВЯЗАННЫЙ С ОСОБЕННО ВЫСОКИМ РИСКОМ САМОПОВРЕЖДЕНИЙ

Перевод: Жоров Е. Н.

Исследование в *BMC Psychiatry* показало, что подростковая депрессия не является клинически однородной. У примерно пятой части пациентов авторы выделили «смешанно-дизрегулированный» профиль с сочетанием депрессивных, тревожных, раздражительных и циклотимических черт, и именно эта группа оказалась связана с наиболее тяжёлыми несуицидальными самоповреждениями.

Связь между этим профилем и самоповреждениями статистически частично объяснялась дезадаптивными стратегиями когнитивной регуляции эмоций, прежде всего катастрофизацией и руминацией. Авторы считают, что это делает подростковую депрессию более подходящей мишенью для персонифицированной оценки риска, чем для универсального подхода «одна депрессия – одно лечение».



В анализ вошли 282 подростка 10–19 лет с большим депрессивным расстройством по DSM-5. Средний возраст составил 14,5 года, 68,5% выборки были девочками, а 86,2% участников сообщили как минимум об одном эпизоде несуйцидального самоповреждения за последний год. Для оценки использовали шкалу аффективных темпераментов TEMPS-A, опросник когнитивной регуляции эмоций и шкалу подростковых самоповреждений. Затем авторы применили латентный профильный анализ, то есть person-centered подход, позволяющий выделить не отдельные симптомы, а клинические подтипы по сочетанию черт.

В результате были выделены три профиля. Первый, «устойчивый/низкорисковый», составил 32,6% выборки и характеризовался низкой выраженностью негативных темпераментных черт. Второй, «тревно-депрессивный», охватил 46,1% подростков и включал высокие показатели тревожного и депрессивного темперамента при более умеренной раздражительности и циклотимии. Третий профиль, «смешанно-дизрегулируемый», составил 21,3% выборки и отличался одновременным повышением депрессивных, тревожных, раздражительных и циклотимических черт. Именно эта группа показала наиболее тяжёлую клиническую картину.

Различия в самоповреждениях оказались особенно выраженными. Подростки из «смешанно-дизрегулируемой» группы сообщали о средней частоте несуйцидальных самоповреждений 45,2 эпизода в год, тогда как в «тревно-депрессивной» группе этот показатель составлял 18,6, а в «низкорисковой» – 2,15. Распространённость самоповреждений в группе высокого риска достигала 98,8%. Одновременно именно у этих подростков были наиболее выражены дезадаптивные стратегии когнитивной регуляции эмоций, прежде всего катастрофизация и руминация.

Медицинский анализ показал, что связь между «смешанно-дизрегулируемым» профилем и более высокой частотой самоповреждений статистически частично объясняется дезадаптивной когнитивной регуляцией. Иначе говоря, речь идёт не только о более тяжёлом аффективном профиле как таковом, но и о специфическом способе переработки эмоционального напряжения, при котором подросток застревает в руминации и катастрофизации. На уровне клинической логики это делает самоповреждение не просто сопутствующим симптомом депрессии, а вероятным поведенческим выходом из плохо регулируемого аффективного состояния.



Практическая ценность этой работы в том, что она показывает пределы привычного подхода к подростковой депрессии как к единой категории. Если внутри диагноза существуют разные темпераментные конфигурации, то и риск самоповреждений распределён неравномерно. Для врача это означает, что при оценке подростка с депрессией имеет смысл смотреть не только на тяжесть настроения, но и на раздражительность, циклотимическую нестабильность, особенности эмоциональной регуляции и склонность к руминации. Именно эта комбинация может указывать на более тяжёлую и более опасную клиническую подгруппу.

Что это меняет

Работа поддерживает движение от усреднённой подростковой психиатрии к более точной стратификации риска. Но она одновременно напоминает о границах интерпретации: исследование было поперечным, проведено в одном центре, опиралось на самоотчёт и включало выборку с очень высокой долей самоповреждений, характерной для тяжёлых клинических случаев. Поэтому полученные профили нельзя напрямую переносить на общую популяцию подростков и нельзя использовать как доказательство причинной связи или как критерий будущего перехода к биполярному расстройству. Тем не менее это сильный аргумент в пользу того, что оценка подростковой депрессии должна быть глубже, чем просто подсчёт депрессивных симптомов.

Ссылка на исследование

Liu S, Ma B, Liu Y, Liu X, Li X, Zhang X, et al. Unmasking the “Mixed-Dysregulated” phenotype: latent profiles of affective temperaments and non-suicidal self-injury in adolescents with depression. *BMC Psychiatry*. 2026;26:287. doi:10.1186/s12888-026-07910-8.

PsyAndNeuro.ru

Психиатрия & Нейронауки

Главная
Все публикации
Диагностика
Терапия
Bekhterev AI

